

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

VIGILANZA POST-MARKET DISPOSITIVI MEDICI E IVD (MDR / IVDR)

Area 16 – Business

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO105_00	00	04/05/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Direttore Sanitario + Direttore Lab + RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + Direttore Sanitario + Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura disciplina le attività di vigilanza post-market relative ai dispositivi medici (MDR — Reg. UE 2017/745) e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR — Reg. UE 2017/746) utilizzati da Toscana Diagnostica S.r.l. nelle attività di laboratorio analisi e di diagnostica per immagini, in qualità di utilizzatore (operatore sanitario).

Si applica a tutti i dispositivi e kit IVD in uso a TD: strumentazione di laboratorio (Alinity, Sysmex, Sebia, Vitek, Roche, Liaison, Atras, Ortho, EU-Turbo, iSED, Elitech), reagenti e kit IVD per chimica clinica/ematologia/microbiologia/immunologia/genetica/biologia molecolare, dispositivi di diagnostica per immagini, dispositivi medici di supporto clinico.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
Reg. UE 2017/745 (MDR) artt. 87-92	Vigilanza dispositivi medici
Reg. UE 2017/746 (IVDR) artt. 82-87	Vigilanza dispositivi diagnostici in vitro
MDCG 2023-3 + 2024-1 (Medical Device Coordination Group)	Linee guida operative su vigilanza MDR
MDCG 2024-3 (IVDR vigilance)	Linee guida operative su vigilanza IVDR
D.Lgs. 137/2024 (recepimento sistema sanzionatorio MDR)	Sanzioni nazionali
D.Lgs. 138/2024 (recepimento sistema sanzionatorio IVDR)	Sanzioni nazionali
AIFA — Banca Dati Vigilanza Dispositivi Medici	Canale operativo nazionale
Eudamed	Banca dati europea dispositivi medici (in implementazione progressiva)
TD-SGI-PRO034 rev 01	Qualificazione fornitori critici (per fornitori IVD)
TD-SGI-MOD182	Inventario fornitori ICT (per dispositivi connessi)
TD-SGI-PRO101	Output non conformi (interfaccia per kit IVD difformi)
TD-SGI-PRO092	SEA/RCA Patient Safety (per eventi avversi correlati a IVD)
TD-SGI-MOD209	Tassonomia eventi avversi ICPS WHO

3. Inventario dispositivi soggetti a vigilanza

TD mantiene un inventario aggiornato di tutti i dispositivi medici e IVD in uso. L'inventario include: codice prodotto, fabbricante, classe (per IVD: A, B, C, D ai sensi Allegato VIII Reg. 2017/746; per MDR: I, IIa, IIb, III ai sensi Allegato VIII Reg. 2017/745), numero CE/identificazione UDI, data di immissione in uso presso TD, scadenza, lotto, numero di serie, locale di installazione/uso. L'inventario è coordinato con il MOD050 (Inventario asset) e con il MOD182 (per dispositivi ICT integrati).

Classe IVDR	Definizione (Allegato VIII)	Esempi in TD	Vigilanza
-------------	-----------------------------	--------------	-----------

A	Rischio individuale e per la salute pubblica basso	Reagenti generici, dispositivi di prelievo standard	Vigilanza ordinaria
B	Rischio individuale moderato e/o pubblico basso	Test per allergie, gravidanza	Vigilanza ordinaria + segnalazione incidenti
C	Rischio individuale elevato e/o pubblico moderato	Test per HBV, HCV, HIV (autodiagnosi); test genetici per malattie ereditarie	Vigilanza rinforzata + Periodic Safety Update Report
D	Rischio elevato individuale e per salute pubblica	Test per agenti pericolosi (es. variante VCJD); screening del sangue/organi	Vigilanza massima + Eudamed + valutazione di referenza notificata

4. Tipologie di eventi soggetti a segnalazione

4.1 Incidente grave (art. 87 MDR / art. 82 IVDR)

Si intende un incidente che ha determinato direttamente o indirettamente, può determinare o ha potuto determinare:

- (a) il decesso del paziente, dell'utilizzatore o di altre persone;
- (b) un grave deterioramento — anche temporaneo — dello stato di salute del paziente, dell'utilizzatore o di altre persone (es. errore diagnostico con conseguenze cliniche, esposizione a rischio);
- (c) una grave minaccia per la salute pubblica.

4.2 Tendenze (Field Safety Trends)

Aumento statisticamente significativo di incidenti non gravi o di effetti collaterali attesi che potrebbero impattare sulla sicurezza, anche se i singoli eventi non rientrerebbero nella categoria degli incidenti gravi.

4.3 Field Safety Corrective Action (FSCA)

Azione correttiva sul campo intrapresa dal fabbricante per ridurre il rischio di un incidente grave (richiamo, modifica, ritiro, comunicazione di sicurezza). TD ha l'obbligo di applicare le FSCA comunicate dai fabbricanti e di darne riscontro.

5. Procedura operativa di vigilanza

Step	Attività	Owner	Tempistica
1	Rilevazione di incidente / sospetto incidente / FSCA / non conformità su dispositivo	Chiunque rilevi (operatore, paziente, segnalazione fabbricante)	Senza ingiustificato ritardo
2	Apertura del caso e contenimento immediato (sospensione del dispositivo, isolamento del campione, ritiro del referto)	Direttore Lab + COO	Entro 1 ora dalla rilevazione
3	Classificazione: incidente grave (art. 87 MDR / art. 82 IVDR) / non	Direttore Sanitario + Direttore Lab	Entro 24 ore

	grave / FSCA		
4	Per incidente grave: notifica al fabbricante con riferimento UDI/lotto/serial number	Direttore Lab + Direttore Sanitario	Senza ingiustificato ritardo
5	Per incidente grave: notifica all'AIFA tramite Banca Dati Vigilanza nazionale (modalità telematica)	Direttore Sanitario	Entro 15 giorni (decesso/grave deterioramento) o entro 30 giorni (altri casi gravi)
6	Per FSCA ricevuta: applicazione delle istruzioni del fabbricante (es. ritiro lotto, sostituzione, aggiornamento firmware) + tracciatura	Direttore Lab + IT Manager (per FSCA su dispositivi connessi)	Coerente con tempistica fabbricante
7	Conservazione del dispositivo o di parte di esso fino a chiusura dell'indagine — assenza di alterazioni	Direttore Lab	Fino alla chiusura
8	Cooperazione con il fabbricante e con AIFA durante l'indagine	Direttore Sanitario + Direttore Lab	Continuativa
9	Aggiornamento del registro vigilanza interno (cfr. §6) e del Cruscotto Patient Safety (MOD210)	RSGI + Direttore Lab	Continuativa
10	Lessons learned e CAPA: aggiornamento procedure, formazione, eventuale modifica fornitore	RSGI + COO	Entro 60 giorni dalla chiusura
11	Reporting al Riesame della Direzione semestrale dei casi di vigilanza chiusi	RSGI	Semestrale

6. Registro interno vigilanza

TD mantiene un registro interno di tutti i casi di vigilanza apertura nel corso dell'anno. Il registro contiene: ID caso, data apertura, dispositivo coinvolto (UDI), classe, fabbricante, tipologia (incidente grave / non grave / FSCA / tendenza), descrizione, azioni di contenimento, notifiche effettuate, esito, data chiusura.

7. Sorveglianza periodica

Indipendentemente dagli incidenti, TD effettua sorveglianza periodica:

- (a) verifica annuale dello stato delle certificazioni CE dei dispositivi in uso (rinnovi, sospensioni, revoche);
- (b) monitoraggio bollettini di sicurezza pubblicati da AIFA e Commissione UE;
- (c) verifica periodica dei controlli di qualità interni (CIQ) e delle valutazioni esterne di qualità (VEQ) per identificare derive prestazionali dei kit IVD;
- (d) revisione annuale dell'inventario dispositivi con verifica scadenze e classi.

8. Coordinamento con altri processi del SGI

Processo TD	Coordinamento
PRO034 rev 01 — Qualifica fornitori critici	Verifica certificazioni e capacità di vigilanza dei fornitori IVD critici
PRO101 — Output non conformi	Output non conformi su kit IVD attivano valutazione di vigilanza
PRO092 — SEA/RCA Patient Safety	RCA per eventi avversi correlati a IVD
MOD209 — Tassonomia ICPS WHO	Codifica eventi correlati a dispositivi
MOD210 — Cruscotto Patient Safety	KPI vigilanza incidenti gravi su dispositivi
PRO070 — NIS2	Per dispositivi connessi alla rete (cyber-incident con effetto vigilanza)
PRO018 — ICT Change Management	Per modifiche firmware/software dispositivi
PRO100 — Gestione delle Modifiche	Per modifiche significative da FSCA
MOD198 — Onboarding Sistemi AI	Per dispositivi con componente AI integrata

9. KPI di processo

KPI	Target
% incidenti gravi notificati ad AIFA nei tempi di legge (15-30 gg)	100%
% FSCA ricevute applicate nei tempi indicati dal fabbricante	100%
% inventario dispositivi aggiornato semestralmente	100%
Numero incidenti gravi MDR/IVDR / anno	Tracciato + analisi cause
Tempo medio dalla rilevazione alla notifica AIFA	≤ 7 giorni (target operativo, < 15 gg legali)
% bollettini sicurezza AIFA monitorati e valutati	100%
% audit semestrale registro vigilanza	100%

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	04/05/2026	Prima emissione della Procedura Vigilanza Post-Market Dispositivi Medici e IVD in Area 16 Business in attuazione di MDR (Reg. UE 2017/745 artt. 87-92), IVDR (Reg. UE 2017/746 artt. 82-87), MDCG 2023-3/2024-1/2024-3, D.Lgs. 137/2024 + 138/2024. Inventario dispositivi con classificazione IVDR (A/B/C/D); 3 tipologie di eventi soggetti a segnalazione (incidente grave, tendenze, FSCA); procedura operativa a 11 step con notifica ad AIFA tramite Banca Dati Vigilanza nazionale; registro interno vigilanza; sorveglianza periodica + coordinamento con 9 processi del SGI.	Direttore Sanitario + Direttore Lab + RSGI	AD

